医务社会工作安宁疗护

实务指引

（供内部学习与服务参考）

2026 年 10 月

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

目 录

第一章 什么是安宁疗护 3

第二章 适用人群 4

第三章 适用范围 6

第四章 安宁疗护的主要服务模块及常见干预措施 7

第五章 医务社工对安宁疗护的介入 9

第六章 安宁疗护个案介入实务指引 10

第七章 安宁疗护小组工作介入 19

第八章 安宁疗护社区工作介入 24

参考来源 30

后 记 32

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

第一章 什么是安宁疗护

安宁疗护（Hospice and Palliative Care），是以疾病终末期患者和家属为中心、以多学科协作模式进行的专业服务：通过控制痛苦和不适症状，提供身体、心理、社会和精神等方面的照护和人文关怀，提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严地离世，并减轻亲属的心理哀伤。[1]

世界卫生组织（WHO）将缓和照护（Palliative Care）界定为：通过早期识别、审慎评估和治疗疼痛及其他身体、心理社会、灵性层面的问题，预防和缓解罹患威胁生命疾病的患者及其家属的痛苦，从而改善其生活质量的方法。[2]

一、核心理念

（1）肯定生命，视死亡为自然过程。安宁疗护既不加速死亡，也不延缓死亡，焦点从"治愈疾病"转向"照护生命"。

（2）全人、全家、全程、全队。同时照护患者的身体、心理、社会、灵性四个维度；将家属纳入服务对象；服务贯穿临终全过程并延伸至丧亲之后；由多学科团队共同提供。

（3）缓解疼痛及其他痛苦症状。将症状控制与舒适照护作为基本内容，帮助患者尽可能积极地生活至生命终点。

（4）支持系统。为患者提供活到终点的支持，为家属在患者患病期间及丧亲后的哀伤适应提供支持，包括必要的丧亲辅导。

（5）可与其他治疗并行。WHO 指出，缓和照护可在疾病早期与旨在延长生命的治疗（如化疗、放疗）同时进行。进入安宁疗护阶段，则以患者知情同意为前提，不再实施以治愈为目的的创伤性治疗或抢救。

二、与相近概念的区别

[1]深圳市地方标准 DB4403/T 521—2024《安宁疗护社会工作服务指南》，2024 年 11 月 5 日发布、2024 年 12 月 1 日实施。见全国标准信息公共服务平台：https://std.samr.gov.cn/db/search/stdDBDetailedCNF?id=277BCDF4A98F044EE06397BEA0A0E0E63

[2]World Health Organization. Palliative Care (Fact sheet, 2020). https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care

云南大学青年教师老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

安宁疗护不同于安乐死：它不采取任何主动结束生命的行为；也不同于一般医疗：它不以治愈疾病、延长生存时间为目标，而是以控制症状、维护尊严、提升生命末期的生存质量为目标。换言之，安宁疗护"放弃的是过度治疗，不是照护"。

第二章 适用人群

一、服务对象

1. 疾病终末期患者。经二级及以上医疗机构明确诊断，罹患严重伤病导致器官功能衰竭、病情危重，经现代医学尚无法治愈，预期生存期有限的患者。各地服务规范普遍以"预期生存期在6个月以内"为参考标准，并要求患者或家属知情同意、自愿接受服务约定。

2. 患者家属及主要照顾者。家属是安宁疗护的共同服务对象。患者的临终质量高度依赖家庭系统的稳定，家属亦在照护过程中承受巨大的身心负担，并将在患者离世后经历哀伤，因此政策文本普遍将"减轻亲属心理哀伤"列为服务目标。

二、政策与文件依据

相关政策	要点
《安宁疗护中心基本标准（试行）和安宁疗护中心管理规范（试行）》（国卫医发〔2017〕7号）	规定独立设置安宁疗护中心的基本条件、科室与设备配置（含关怀室/告别室）、管理要求，为机构开展安宁疗护提供设置标准。
《安宁疗护实践指南（2025年版）》（国卫办医政函〔2025〕332号）	现行有效的国家层面实践规范，取代2017年试行版。明确安宁疗护以终末期患者和家属为中心、以多学科协作模式进行，主要内容包括疼痛及其他症状控制、舒适照护、心理精神及社会支持等。
国家安宁疗护试点政策（2017年首批、2019年第二批、2023年扩大）	2017年确定首批5个国家级试点市（区），2019年扩展至71个地区，2023年扩大至3个省级试点及61个市（区）；截至2024年底，国家级试点已覆盖185个市（区），安宁疗护服务网络在全国范围内持续推进。

云南大学青年教师（仅供内部使用 禁止外传）

地方服务规范（如《上海市安宁疗护服务规范》沪卫基层〔2020〕9号、《新疆维吾尔自治区安宁疗护服务规范》2025年）	地方规范进一步细化了准入标准：经执业医师明确诊断的疾病终末期或老年患者，经评估预期生存期在6个月以内，患者或家属同意接受服务约定或协议。新疆规范明确以KPS评分70分以下或PPS评估预期生存期6个月以内作为参照。
《安宁疗护社会工作服务指南》（深圳市地方标准 DB4403/T 521—2024）	国内首个安宁疗护社会工作地方标准，规定服务原则（自决、全人、全家、全程、多学科协作）、服务流程（接案—预估—计划—介入—评估—结案）及尊严疗法、意义疗法、叙事疗法等介入取向，并附录SAS、SDS、预期性悲伤量表（AGS）、社会支持评定量表（SSRS）、患者尊严量表（PDI）等评估工具。

说明：2017年版《安宁疗护实践指南（试行）》（国卫办医发〔2017〕5号）已被2025年版替代；本手册引用的症状控制与舒适照护内容以2025年版为准。[3]

上表所列国家安宁疗护试点沿革数据（首批5个市（区）、2019年71个地区、2023年扩围、截至2024年底覆盖185个市（区））引自公开发表的研究综述。[4]

上表所列地方规范中，上海市以"经评估预期生存期在6个月以内、患者或家属同意接受服务约定"为服务对象条件[5]，新疆维吾尔自治区以"KPS评分70分以下，或经姑息功能量表（PPS）评估预期生存期在6个月以内"为参照[6]。

三、实务提示

[3]国家卫生健康委办公厅《关于印发安宁疗护实践指南（2025年版）的通知》（国卫办医政函〔2025〕332号），2025年8月1日印发，2017年试行版同步废止。见深圳市卫健委政府信息公开页：http://wjw.sz.gov.cn/gkmlpt/content/12/12350/post_12350391.html

[4]安宁疗护试点沿革：2017年首批5个市（区），2019年第二批71个地区，2023年扩大至3个省级试点及61个市（区），截至2024年底国家级试点覆盖185个市（区）。见昆山杜克大学全球健康研究中心：《安宁疗护如何融入癌症照护体系》（2026年）。https://globalhealth.dukekunshan.edu.cn/zh-hans/calab-publication/hospice-care-in-china/

[5]《上海市安宁疗护服务规范》（沪卫基层〔2020〕9号），2020年8月发布，规定服务对象为经评估预期生存期在6个月以内、且患者或家属同意接受服务约定或协议的疾病终末期或老年患者。

[6]《新疆维吾尔自治区安宁疗护服务规范》（2025年印发）第五条：服务对象为经二级及以上医疗机构明确诊断的疾病终末期患者，KPS评分70分以下，或经姑息功能量表（PPS）评估预期生存期在6个月以内。见新疆维吾尔自治区卫健委官网：https://wjw.xinjiang.gov.cn/hfpc/zcwj2/202512/558ee3d8b2b04171987ad8866a7b85aa.shtml

云南大学青禾社会实践队（仅供内部使用，禁止外传）

各地对"预期生存期"的把握和医保结算准入标准不完全一致：一些地方按6个月掌握，纳入医保按床日付费结算的地区常要求更严格（如KPS评分50分以下、预期生存期不超过3个月、签署知情同意书、不再接受手术及放化疗等治愈性治疗）。实际执行中，以属地卫生健康和医保部门的规定为准。

第三章 适用范围

一、服务场所

（1）独立设置的安宁疗护中心（病区）。[7]须符合国卫医发〔2017〕7号文件规定的基本标准和管理规范，设有关怀室（告别室）。

（2）医疗机构内的安宁疗护床位。综合医院、中医医院、专科医院可在肿瘤科、老年科、疼痛科等相关科室设立安宁疗护床位或工作小组。

（3）医养结合与福利机构。养老机构、社会福利院、护理院等可为机构内的疾病终末期老年人提供安宁疗护服务。

（4）社区与居家。社区卫生服务中心、乡镇卫生院可结合家庭病床、上门服务等开展居家安宁疗护。

二、服务形式

包括门诊服务、住院服务、机构内服务与居家服务。患者可在不同场所之间转介，服务随患者所在场景延伸。

三、服务团队

以执业医师、执业护士为核心，根据实际配备医务社会工作者、心理咨询师、药师、营养师、康复治疗师、志愿者等，形成分工明确、协作运转的多学科团队。医务社工是团队中负责心理社会评估、情绪与家庭工作、资源链接及团队协调的专业成员。

四、服务内容边界

[7]国家卫生计生委《关于印发安宁疗护中心基本标准（试行）和安宁疗护中心管理规范（试行）的通知》（国卫医发〔2017〕7号），2017年2月印发。见国家卫生健康委官网：https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/201702/26bf0da4ccd6423992953d45c9bb8279.shtml

云南大学青木书法实践队（仅供内部使用，禁止外传）

安宁疗护的服务内容为：症状控制（疼痛及其他症状）、舒适照护、心理精神及社会支持、人文关怀与善终服务。进入安宁疗护须签署知情同意；除对症、支持性措施外，不再实施以治愈为目的的创伤性治疗，各地对"不实施心肺复苏、插管等抢救"的具体规定以当地规范为准。

第四章　安宁疗护的主要服务模块及常见干预措施

一、症状控制

依据《安宁疗护实践指南（2025 年版）》，终末期患者常见症状包括疼痛、呼吸困难、咳嗽咳痰、咯血、恶心呕吐、呕血便血、腹胀、水肿、发热、厌食、便秘、尿潴留、失眠、谵妄等。干预要点如下：

（1）疼痛管理。动态评估疼痛的部位、性质、程度及影响因素，选择合适评估工具（数字评分法 NRS 0—10 分、视觉模拟法 VAS 等）；遵循 WHO 三阶梯镇痛原则，按阶梯选药、按时给药、口服优先、个体化滴定，并关注药物不良反应。

（2）呼吸困难。评估诱因与伴随症状，取舒适体位、开窗通风、放松疗法，必要时遵医嘱氧疗或药物缓解。

（3）谵妄、失眠、便秘等。先寻找并处理可逆诱因（感染、药物、尿潴留、便秘等），保持环境安静与熟悉，减少不必要刺激，必要时遵医嘱小剂量用药。

二、舒适照护

包括床单位管理、口腔护理、皮肤与会阴护理、协助进食饮水、翻身与卧位管理、轮椅与平车使用等基础护理，目标是保持患者清洁、舒适、无压疮，维护隐私与尊严。

三、心理、精神及社会支持

（1）情绪识别与应对。使用恰当工具筛查焦虑、抑郁程度及自杀倾向；鼓励患者表达感受，运用倾听、沉默、抚触等技巧，指导深呼吸、放松训练、听音乐、按摩等缓解焦虑；对明显抑郁或重度焦虑者转介心理治疗师或遵医嘱药物干预，对自杀倾向者及早防范。

（2）死亡教育与沟通。以患者可接受的方式协助其面对死亡议题，促进患者与家

云南大学临床护理老师团队（仅供内部使用，禁止外传）

属之间的真情表达与四道人生（道谢、道爱、道歉、道别）沟通。

（3）社会支持系统。评估患者人际关系与家属支持状况，鼓励亲友陪伴，指导患者积极寻求并运用社会支持。

（4）尊重患者权利。尊重其价值观、信仰与民族习俗，保障知情权和隐私权，允许患者及家属参与照护决策。

四、家庭支持与哀伤辅导

对照顾者开展照护知识与死亡教育，协助召开家庭会议以澄清治疗目标与照护意愿；协助有需要的家庭讨论预立医疗照护计划（生前预嘱）；患者离世后，为家属提供善后协助与丧亲辅导，必要时链接哀伤支持资源并随访。

五、常见心理社会干预方法

干预方法	适用对象	核心做法
尊严疗法	感到尊严受损、无价值感的临终患者	经训练访谈者引导患者回顾一生、传递人生经验与期许，生成"代际传承文件"（文字或录音）留给家人，提升尊严感与意义感。
意义疗法	存在焦虑、意义感缺失者	协助患者在不可避免的苦难中发现个人意义，重建价值感。
叙事疗法 / 生命回顾	需要生命整合、处于哀伤中的患者	以照片、旧物、口述史等媒介，按人生阶段回顾经历，接纳圆满与遗憾，完成自我整合。
家庭治疗 / 家庭会议	家庭沟通障碍、决策冲突、未竟事务	分别会谈与共同会谈结合，搭建安全对话空间，促进情感澄清与共识达成。
艺术、音乐、园艺治疗	情绪需要表达与舒缓的患者及家属	以创作、聆听、种植等低门槛活动承载情绪、转移痛苦、重获掌控感。

云南大学青未了老实践队（仅供学习使用，禁止外传）

认知行为取向	焦虑、抑郁伴明显负性认知者	识别并重构灾难化等不合理认知，配合放松训练与行为激活。
游戏治疗	患儿及其兄弟姐妹	以游戏为媒介表达难以言说的情绪与恐惧。

上述介入取向以深圳市地方标准 DB4403/T 521—2024《安宁疗护社会工作服务指南》所列方法为基础整理。[8]

第五章 医务社工对安宁疗护的介入

一、专业定位与角色

角色	主要职责
评估者	对患者的生理—心理—社会—灵性状况及家庭系统开展综合评估，动态识别需求与风险（如自杀风险、哀伤风险、照护者耗竭）。
直接服务者	运用个案工作、小组工作、社区工作方法，提供情绪支持、哀伤辅导、家庭工作、死亡教育协助等直接服务。
协调者	作为多学科团队的沟通桥梁，参与团队查房与个案讨论，促进医疗、护理、心理、社工、志愿服务的无缝衔接。
资源链接者	链接医疗救助、慈善资源、政策福利、志愿服务等正式与非正式资源，构建患者的社会支持网络。
教育者	向患者家属及公众开展死亡教育与照护知识教育，提升家庭照护能力与社会死亡素养。

云南大学青年护理实践队（仅供内部交流，禁止外传）

倡导者	维护患者自主权与尊严，在团队与制度层面倡导以患者及家属为中心的照护。

近年研究基于系统评价提出安宁疗护社工的 E-CARE 五维核心能力框架：伦理（Ethics）、协调（Coordination）、评估（Assessment）、资源分配（Resource Allocation）、教育（Education），可作为社工专业能力建设与考核的参照。[9]

二、服务原则与服务流程

服务原则：服务对象自决、全人服务、全家照顾、全程服务、多学科协作。

服务流程：按照社会工作通用过程模式，依次为接案、预估、计划、介入、评估、结案六个环节。需具备特定条件时，可采用第四章第五部分所列专业介入方法。

第六章 安宁疗护个案介入实务指引

本章依据医务社工个案工作通用流程及本机构个案记录规范整理，为一般性实务指引，不涉及任何真实个案。

一、个案工作流程

接案（识别与转介、知情同意、危机程度初判）→ 预估（生理—心理—社会—家庭—经济多维度问题与需求评估，完成基线测量）→ 计划（商定总目标与具体目标，选定理论模式与干预方法，签订服务契约）→ 介入（分阶段实施，动态评估与调整）→ 评估（前后测对比与质性反馈）→ 结案（目标达成确认、支持网络交接、回访计划）。

云南大学青禾助老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

[9]福建医科大学等《安宁疗护社会工作核心能力框架构建：基于 E-CARE 模型的系统评价》，发表于 BMC Palliative Care（2025），提出伦理（Ethics）、协调（Coordination）、评估（Assessment）、资源分配（Resource Allocation）、教育（Education）五维核心能力框架。



云南大学青天护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

二、需求评估：维度、工具与判定

评估遵循"量表测量＋访谈观察＋关键他人核实"相结合的原则。先以标准化工具判定"有没有问题、严重程度如何"，再以访谈澄清问题的性质与需求，据此选择理论框架并制定干预方案。常用工具如下：

评估维度	工具	结果判定（参考）	指向的需求
焦虑	焦虑自评量表 SAS（Zung）；广泛性焦虑量表 GAD-7	SAS 标准分≥50 提示焦虑：50—59 轻度、60—69 中度、≥70 重度；GAD-7：0—4 无、5—9 轻度、10—14 中度、15—21 重度	情绪安抚、放松训练、认知干预
抑郁	抑郁自评量表 SDS（Zung）；患者健康问卷 PHQ-9	SDS 标准分≥53：53—62 轻度、63—72 中度、≥73 重度；PHQ-9≥10 提示中度及以上抑郁	心理支持、行为激活、转介心理/精神科
自杀风险	直接访谈（意念、计划、手段、意图）＋风险评估表	存在明确计划、可及手段或强烈意图者列为高危，立即启动危机介入	安全优先、危机干预
预期性哀伤	预期性悲伤量表 AGS；晚期癌症患者预期性哀伤量表 PGAC	依所用版本常模判定轻、中、重度	哀伤辅导、生命回顾、家庭会谈
复杂性/延长哀伤	复杂性哀伤量表 ICG（Prigerson）；ICD-11 延长哀伤障碍标准	ICG 总分≥25 提示高风险；ICD-11 要求丧亲后症状持续逾 6 个月且造成功能损害	转介专业哀伤治疗，社工支持性跟进

云南大学青年社会实践队（仅供内部使用，禁止外传）

社会支持	社会支持评定量表 SSRS（肖水源）	含主观支持、客观支持、支持利用度三个维度，总分越低支持越不足	资源链接、支持网络构建、照顾者支持
功能与生存期	卡氏功能状态量表 KPS；姑息功能量表 PPS	多地以 KPS≤70 或 PPS 提示预期生存期≤6 个月作为服务匹配参考	服务层级与强度匹配
症状负担	埃德蒙顿症状评估量表 ESAS；疼痛 NRS	各症状 0—10 分自评，动态追踪	转介医护处理、症状管理配合
尊严感	患者尊严量表 PDI	分数越高尊严困扰越重	尊严疗法、意义建构
老年抑郁	老年抑郁量表 GDS（30 项版）	总分≥11 分提示抑郁可能，≥21 分提示中重度，适合老年人群筛查	抑郁情绪干预、陪伴与哀伤疏导
日常生活能力	Barthel 指数（ADL）	评分越低提示生活依赖程度越高，需匹配相应照护与协助安排	照护资源协调、生活支持
生命意义感	生命意义感量表（如 PIL）	低分提示无意义感与自我价值感低下	生命回顾、意义建构干预
哀伤的质性识别	哀伤三要素观察（失落、孤独、未完成事件）	三要素明显者即提示哀伤辅导需求，即使量表得分未达临界值	哀伤辅导、未竟事宜处理

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

孤独感	孤独感量表（如UCLA 孤独量表简版）	高分提示孤独与社会隔离	陪伴服务、社会交往重建

SAS/SDS 标准分＝粗分×1.25；上述界值为国内通行用法，具体以各工具手册及所用版本的常模为准。[10]ICG 总分≥25 为国际哀伤研究常用界值，ICD-11 将延长哀伤障碍列为独立诊断单元（丧亲后持续逾 6 个月且功能受损）。[11]

三、理论依据及其回应的需求

评估确认问题与需求后，依据问题性质选择理论框架，用以解释"问题从何而来"，并确定干预方向与目标。常用理论如下：

理论	提出者/来源	核心观点	回应的需求
ADAPTS 哀伤评估与干预配对模式	周燕雯（香港大学）	哀伤反应呈现六个面向：异常情绪、功能失调认知、适应困难、生理症状、创伤反应、分离痛苦。干预前先评估并定位个体主导的痛苦面向，再配对针对性方法，实现"把对的照顾给对的人"，避免"一刀切"式哀伤辅导。	哀伤者差异化大、需求各异的精准评估与干预需求
持续联结理论	Klass、Silverman、Nickman（1996）	哀伤的目标不是切断与逝者的关系，而是将其转化为以记忆、仪式、传承为载体的持续性心理联结。	与逝者保持联结、完成未竟关系的心理需求

[10]Zung, W. W. K. (1971). A rating instrument for anxiety. Psychosomatics. SAS、SDS 标准分＝粗分×1.25，界值与分级为国内临床及科研通行用法。

[11]Prigerson 等编制复杂性哀伤量表（Inventory of Complicated Grief, ICG），总分≥25 分提示延长哀伤高风险；ICG≥25 为国际哀伤研究常用界值。WHO《国际疾病分类第十一次修订本》（ICD-11）将"延长哀伤障碍"（Prolonged Grief Disorder）列为独立诊断单元，要求丧亲后症状持续超过 6 个月并导致功能受损。

云南大学青禾护老实践队（仅供内部交流，禁止外传）

依恋理论	Bowlby	丧亲激活个体的依恋系统，分离痛苦强度与依恋类型相关：安全依恋者哀伤适应相对平稳，焦虑/矛盾依恋者更易出现强烈而持久的分离痛苦。依恋风格可作为哀伤风险筛查的参考维度。	分离痛苦、个体化哀伤风险的识别与安抚
生命周期理论	Erikson	老年期的发展任务是"自我整合对绝望"：能够回顾一生并接纳其圆满与遗憾者获得智慧感，得以安然面对终点；整合失败者陷入对死亡的恐惧与绝望。生命回顾是完成该任务的主要方法。	生命意义感、自我整合与"善终"的心理需求
叙事治疗与生命回顾	White & Epston；Butler（1963）	人借助“故事”理解自身生命；引导服务对象讲述、整理并重构生命故事，可重建自我认同与生命意义	生命意义感缺失、自我认同困扰
尊严疗法	Chochinov（加拿大）	通过结构化人生回顾与寄语整理，协助临终者确认自身价值、留下传承，维护临终尊严	尊严维护、人生价值传承
意义建构理论	Neimeyer	丧亲的本质是原有意义世界的破碎，适应的关键在于重建意义、重新安放与逝者的关系	复杂性哀伤、意义重建
社会支持理论	Caplan、Cassel 等	支持网络兼具工具性与情感性功能，可缓冲压力；正式支持与非正式支持需协同动用	支持网络薄弱、孤独
优势视角	Saleebey	聚焦服务对象的能力、资源与成功经验，而非问题与缺陷，	无用感、自我否定

云南大学青禾社会实践队（仅供内部使用，禁止外传）

		以优势为改变的基础	
任务中心模式	Reid & Epstein	短程介入，与服务对象共同确定具体、可操作的任务并分步完成，以任务达成推动改变	目标具体、需限期达成的个案

ADAPTS 模式[12]；持续联结理论[13]；依恋理论[14]；生命周期理论[15]

四、常见问题类型、干预参考线与干预方法

问题类型	评估工具与干预参考线	主要干预方法
死亡焦虑 / 焦虑情绪	SAS≥60（中度）或 GAD-7≥10；或主观痛苦明显、影响睡眠与进食	放松训练、正念呼吸、认知重构、生命教育；配合园艺、音乐等转移性活动；重度者转介心理治疗。
抑郁情绪	SDS≥63（中度）或 PHQ-9≥10	心理支持、行为激活、生命回顾；中重度转介心理或精神科评估。
自杀风险	有明确意念、计划或手段；量表筛查阳性	危机介入模式：制定安全计划、消除环境中危险因素、加强巡视与监护、多方联动、必要时医疗转介；生命安全优先于一切服务议程。

[12]ADAPTS 模型为香港大学周燕雯（Amy Chow）教授提出的哀伤评估与干预配对框架，六个面向为：Anomalous Emotions（异常情绪）、Dysfunctional Cognition（功能失调认知）、Adjustment Challenges（适应困难）、Physical Symptoms（生理症状）、Traumatic Responses（创伤反应）、Separation Distress（分离痛苦）。见 Hospis Malaysia《Berita Hospis》2024 年第 1 期对周燕雯教授的介绍。https://hospismalaysia.org/wp-content/uploads/2024/04/Berita-Hospis-Issue-1-2024-2.pdf

[13]Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). (1996). Continuing Bonds: New Understandings of Grief. Taylor & Francis. 另见北京师范大学心理学部"中国哀伤研究与干预国际研讨会"专家简介（周燕雯教授条目）。https://psych.bnu.edu.cn/xwzx/hdyg/11abec6d74804605afd100a160086036.htm

[14]Bowlby, J. Attachment and Loss 三部曲（1969/1973/1980）, Basic Books. 依恋理论将丧亲反应理解为依恋系统被激活后的分离反应。

[15]Erikson, E. H. Childhood and Society (1950). 埃里克森心理社会发展理论将老年期（65 岁以上）的发展任务界定为"自我整合对绝望"（ego integrity vs. despair）。

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止传）

预期性哀伤 / 丧亲哀伤	AGS/PGAC 提示中重度；丧亲早期情绪崩溃、社会功能受损	哀伤辅导（正常化哀伤、鼓励表达）、生命回顾、持续联结取向的纪念活动（整理遗物、制作纪念册）、家庭会谈。
复杂性 / 延长哀伤	ICG≥25，或符合 ICD-11 延长哀伤障碍标准	转介专业哀伤治疗（如延长哀伤治疗），社工提供支持性跟进与资源链接。
社会支持不足	SSRS 各维度得分偏低、支持网络单一	链接正式支持（医护、社工、政策、慈善），激活非正式支持（家属、朋辈、志愿者），组织或转介支持小组。
家庭沟通障碍 / 未竟事务	家庭访谈、家庭结构图评估发现沟通回避或冲突	家庭会议、分别会谈＋共同会谈、生前预嘱沟通协助；社工保持中立协调者角色，不替代家庭决策。
经济与政策需求	经济收入、医保与救助政策核查	医疗救助与慈善资源链接、政策解答、事务性协助。
生命意义感缺失 / 自我价值感低	生命意义感量表低分；持续出现“无用”“拖累家人”等自我否定表述	生命回顾、生命意义树（根—枝—叶—花—果）、人生故事手账本、尊严疗法、生命故事分享会等叙事性干预，可辅以影像回顾。
老年抑郁情绪	GDS≥11 分提示抑郁可能，≥21 分提示中重度	陪伴访谈、文娱活动破冰、哀伤疏导；中重度或持续高分者转介精神心理科。
躯体症状痛苦 / 舒适照护需求	NRS≥4 分且影响睡眠或持续加重；ADL 下降提示依赖加重	联动多学科调整镇痛与护理方案；以怀旧音乐、棋牌、手工等转移注意力；建立护工—医护—家属—社工四方联动机制。
孤独与社会隔离	孤独感量表高分；社会生态系统图显示社交断裂、回避集体活动	以兴趣活动（棋牌、老歌等原有爱好）破冰建立关系；链接院内同伴与集体活动；搭建家庭线上陪伴约定（如每周视频、每月探视）。
数字生活适应困难	观察评估：不能独立使用通	适老化数字教学（微信语音视频、音乐软

云南大学青天护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

	讯、娱乐类智能设备	件等），小步子反复实操并布置家庭练习；尊重案主自主取舍，身体条件不允许的项目不作硬性目标。
防御性强、抗拒倾诉的丧亲者	访谈中回避丧亲话题、拒绝深入，初期防御明显	以兴趣活动先行破冰建立信任；分层渐进引入哀伤议题，设置随时暂停的安全约定；以口述告别信、书信录音等完成未竟事宜，避免直接触碰创伤。

五、分阶段实施要点

第一阶段：关系建立与基线测量。以陪伴者姿态开展初次会谈，完成知情同意；澄清核心困扰，完成焦虑、抑郁、哀伤、社会支持等基线测量；探索家庭系统；与服务对象商定目标，签订服务契约。

第二阶段：计划制订。依据所选理论将抽象需求转化为具体、可衡量、有时限的目标，明确双方角色与任务；发掘服务对象兴趣与优势，使计划贴合其意愿。

第三阶段：计划实施。按方案开展会谈与活动，常见内容依次为：危机干预与安全计划（如有自杀风险，置于首位）、情绪稳定化训练、生命回顾、哀伤辅导、家庭会谈、资源链接。执行中坚持动态评估——当服务对象当下状态不适宜推进既定议程时，优先情绪安抚，灵活调整节奏。

第四阶段：成效评估与结案。以后测对比基线，量化症状缓解程度；收集服务对象满意度及关键他人（家属、护工、医护）的质性反馈；确认目标达成后结案，完成支持网络交接并约定回访安排。

六、效果评估方法

（1）基线测量法：介入前、中、后定期复测量表，对比变化幅度；

（2）服务对象影响评估：满意度测量、差别影响分析（区分改变源于介入还是其他因素）、关键他人访谈；

（3）任务达成与目标实现程度测量：对具体任务和目标逐项核对完成度；

（4）过程评估：检视会谈是否按结构开展、干预技巧运用是否得当、记录是否完整规范，结合督导反馈持续改进。

云南大学临床督导实践队（仅供内部使用，禁止外传）

七、实务总结

（1）生命优先。自杀风险动态监测贯穿全程，危机干预优先于一切服务议程。

（2）身心社灵整合。慢性终末期患者的心理痛苦常与躯体症状互为条件（如症状—恐惧的条件反射），需与医护团队联动，身心同步干预。

（3）理论服务于需求。先评估、再选理论、后干预：理论用于解释问题与指导方向，不作机械套用。

（4）动态评估与弹性调整。每次接触均重新评估状态与风险，议程服从于服务对象当下的承受能力。

（5）伦理守则。知情同意、保密及保密例外（存在自伤伤人风险时）、尊重自决与文化信仰，涉及财产等敏感议题时保持中立，不替代家庭决策。

（6）团队联动与转介边界。明确社工与医护、心理治疗的职责边界，中重度精神心理症状及时转介，专业问题不越位处理。

第七章 安宁疗护小组工作介入

一、小组工作的定位与适用情形

小组工作以具有共同处境与共同需求的患者或家属为对象，通过有目标、有结构的小组活动，实现情绪支持、知识技能传递、同伴互助与意义建构。与个案工作分工互补：个案深入处理个人化、危机性问题；小组处理共性需求，提供同伴支持与"哀伤不孤独"的接纳场域，且更节省专业人力。家属与患者经小组识别出高危成员时，应及时转介个案深度服务。

二、常见小组类型

小组类型	服务对象	主要目标	规模与频次（实务参考）
住院期家属支持小组	安宁疗护住院患者的主要照顾者	照护赋能、情绪减压、四道人生情感梳理、哀伤预备	封闭小组 6—8 人，每周 1

云南大学青年社会实践队（仅供内部使用，禁止外传）

			次，每次约 60 分钟，共 6 次
居丧家属哀伤辅导小组	亲人离世后的居丧家属	哀伤正常化、情绪表达与承载、躯体调适、生活重建、与逝者持续联结	封闭小组 6 人左右，每周 1 次，每次 60 分钟，共 6 次
患者支持小组	病情相对稳定、体力允许的终末期患者	情绪表达、生命回顾、社会联结、意义建构	小组人数从少到多，单元短时长、坐位活动为主
照护团队同辈支持小组	安宁疗护团队医护人员、社工	替代性创伤预防、减压、团队凝聚力	按团队需要不定期开展
死亡焦虑干预小组	养老机构中存在不同程度死亡焦虑的老年入住者（认知功能正常）	无憾感、掌控感与生命意义感提升，死亡焦虑缓解	封闭小组 8—10 人，每周 1 次，每次 60—70 分钟，共 8 次

三、常用理论

理论	核心观点	在小组中的应用
社会支持理论	支持网络兼具工具性支持与情感性支持	搭建同质家属互助平台，打破"独自承压"的孤立状态，获得经验借鉴与共情陪伴。
哀伤双轨模型（Rubin）	哀伤适应沿"丧亲经历"与"生活功能"两条轨道展开，须双线并进	情绪工作之外，同步安排作息、饮食、园艺等生活重建环节，避免只谈情绪、不顾日常。
持续联结理论	与逝者的关系可转化为以记忆、仪式、纪念物为载体的持续性心理联结	书信、心愿串珠、纪念封存盒等媒介，协助家属与逝者完成"跨越生

云南大学安宁疗护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

		死的对话"（详见第六章理论表）。
表达性艺术治疗	非语言媒介可承载难以言说的情绪	沙盘、手作、串珠、绘画等低门槛活动，适配习惯压抑哀伤情绪的家属。
怀旧疗法	正向回忆有助于提升心理韧性	以老照片、温暖瞬间分享为切入，从与逝者相伴的积极体验中汲取前行力量。
情绪 ABC 理论（Ellis）	情绪困扰源于对事件的不合理信念，调整认知可改善情绪	纠正"安宁疗护＝放弃治疗""悲伤外露是软弱"等认知误区，消解愧疚与自责。
四道人生	道谢、道歉、道爱、道别四步完成情感闭环	分节推进四道梳理：前两节铺垫，第三至五节分别完成道爱、道谢、道歉、道别，第六节巩固闭环。
预感性哀伤与哀伤辅导	丧亲前的预期性哀伤可提前疏导	面向住院期家属开展哀伤预备与死亡教育，降低丧亲后复杂性哀伤风险。
死亡焦虑综合模型（Tomer & Eliason）	死亡焦虑受过去遗憾、未来遗憾与意义感缺失三个因子驱动，意义感为主要中介因子	围绕无憾感、掌控感、生命意义感三个可干预因子设计单元，直接面向死亡焦虑本身工作。
生命回顾与自我整合	系统回顾一生可促进自我整合，提升人生接纳与无憾感（Butler；Erikson）	以生命画卷、未寄出的信等回忆与和解环节，完成正向回顾与遗憾接纳。
自我决定理论	自主、胜任、归属三种基本心理需要的满足提升心理福祉	帮助老年组员识别机构生活中的自主空间，通过"小决定"实践重获掌控体验。
意义疗法	意义感是心理健康的核心资源，可通	从人生经历、人际陪伴与日常小事

云南大学养护中心实践课（仅供内部使用，禁止外传）

（Frankl）	过价值实现与态度选择获得	中挖掘生命价值，建构稳定的意义感。

哀伤双轨模型[16]；情绪 ABC 理论[17]；四道人生[18]；死亡焦虑综合模型[19]

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

[16]Rubin, S. S. (1999). The Two-Track Model of Bereavement: Overview, Retrospective, and Recent Developments. Death Studies, 23(8). 哀伤双轨模型认为丧亲适应沿"丧亲经历"（与逝者的关系、死亡的影响）与"生活功能"（日常功能、身心健康）两条轨道展开，干预须双线并进。

[17]Ellis, A. (1962). Reason and Emotion in Psychotherapy. 情绪 ABC 理论认为，情绪困扰主要源于对事件的不合理信念（B），而非事件本身（A），通过调整认知可改善情绪反应（C）。

[18]四道人生（道谢、道歉、道爱、道别）是华人安宁疗护领域通行的灵性关怀与生命回顾方法，通过分步、温和的情感梳理，协助家属完成未竟的情感表达，国内安宁疗护实务文献与机构实践广泛采用。

[19]Tomer, A., & Eliason, G. (1996). Toward a comprehensive model of death anxiety. Death Studies, 20(4), 343—365. 该模型认为死亡焦虑受过去相关遗憾、未来相关遗憾与意义感缺失三个因子驱动，其中意义感缺失为主要中介因子，为死亡焦虑的结构化小组干预提供了可操作的靶点。

四、小组工作流程

需求评估（共性问题识别）→ 方案设计（目标、单元结构、物资、伦理规则）→ 招募与筛选（自愿报名，排除处于急性精神心理危机者）→ 订立小组契约 → 分节实施（每节含核心目标、流程、物资、评估指标）→ 总结评估与结案（回顾、仪式、后续支持告知）→ 资料归档。两类主题小组均以封闭式为宜，保证团体稳定性与安全感。



云南大学青禾护老实践（仅供内部使用，禁止外传）

五、小组带领要点与伦理

温和原则：不逼迫发言、不强迫回忆、不强制书写，冥想可睁眼静坐，不善书写可口述由社工代笔，全程允许安静独处；多元包容：不评判情绪深浅与表达方式；严格保密：书信与分享内容密封自持、不外传；尊重自愿与安全优先：任何环节可中途退出，情绪崩溃即暂停安抚。

六、风险防控与高危转介

躯体不适：每期开场询问身心状态，搭配安神芳香物资，不适即叫停休息；过度宣泄：坚持温和导向，不深挖创伤，情绪失控即切换放松环节；物资安全：剪刀、精油等由社工统一收发；脱落预防：灵活适配照护作息，缺席者课后补梳理与回访。高危指征（长期重度失眠、持续自我否定、轻生念头）一经发现，立即安抚并转介个案深度辅导与专业心理资源。

七、小组评估与归档

过程评估：出席率、参与度、带领者观察记录与每节即时反馈；结果评估：简易情绪脸谱打分、满意度问卷，有条件时可加用 SAS/SDS、PGAC/AGS、ICG、照顾者负担量表（ZBI）等做前后测对比；归档：签到表、过程记录、作品影像、督导台账。书信等私密材料密封后由本人保管，如需存档须经本人同意。

第八章 安宁疗护社区工作介入

一、社区工作的定位与适用情形

社区工作是安宁疗护服务体系的"前端"与"底座"：通过公众宣传教育与专业人员培训，提升社区居民与照护者对安宁疗护的认知与接受度，营造不避讳谈论死亡的社区氛围；通过资源联动，打通医疗机构、养老机构、社区组织与志愿网络之间的转介通道。与个案、小组分工互补：个案与小组服务患者及家属的"点"，社区工作面向公众与环境的"面"，三者共同支撑"全人、全家、全程、全队"的服务理念。

云南大学肯宁安老实践队（仅供内部使用，勿上外传）

二、常见社区服务形式

服务形式	服务对象	主要目标	组织方式（实务参考）
公众宣传教育活动	社区居民、患者及家属	普及安宁疗护知识、纠正认知误区、教授病情沟通技巧	“宣讲＋情景模拟＋体验式活动”，单场约2—3小时
专业人员专题培训	医护、社工等专业技术人员	生前预嘱、家庭支持、文化因素与医疗决策等实务能力提升	专家授课＋案例解析＋情景模拟，每场1—2小时
社区死亡教育课程	老年人及其家属	死亡态度调适、生死认知正常化、生命意义探索	系列课程或工作坊，小团体、多节次
社区资源联动	社区、养老机构、志愿组织	服务转介衔接、志愿网络培育、丧亲家庭社区支持	协议合作、个案转介机制、志愿者培训

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

三、社区工作的理论依据

理论	核心观点	在社区工作中的应用
知信行模式（KAP）	知识是态度与行为改变的基础，认知提升可带动接受度提升	以知识普及为宣教起点，逐步引导态度转变与沟通行为实践。
增能理论（Solomon）	协助服务对象获得掌控自身处境的能力与资源	帮助居民掌握病情沟通技巧与医疗决策知识，提升面对临终议题的自主能力。
社区工作三大模式（Rothman）	地区发展、社会策划、社会行动三种基本介入策略	宣教活动以社会策划为主，结合地区发展培育社区互助网络。
死亡教育系统理论	死亡教育在认知、情感、行为三个层面促进调适	活动设计兼顾知识讲授、情绪体验与行为演练，避免单一说教。
文化敏感性视角	生死观、家庭权威结构与宗教信仰影响医疗决策	活动设计尊重本地文化禁忌，借情景模拟温和处理家庭沟通冲突。

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

四、社区工作流程

社区需求评估（问卷调查、社区走访，了解认知水平与需求）→ 方案设计（主题、形式、对象、分工）→ 资源链接（医疗机构、社区居委会、养老机构、公益项目、志愿者）→ 宣传招募 → 活动实施（知识宣讲＋体验互动＋现场咨询）→ 评估反馈（知识知晓率、满意度、意见收集）→ 持续跟进（咨询登记对象的转介与回访、系列活动规划）。



云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

五、实务活动方案

（一）生前预嘱与医疗意愿专题培训（面向专业人员）。目标是帮助一线医护人员与社工厘清概念边界、掌握生前预嘱文本与沟通方法，把"选择权"交还给患者的理念落到实务：

环节	内容要点
概念辨析	尊严死与安乐死的区别：不主动加速、也不人为延迟死亡，可撤除或拒绝维生系统，让死亡自然来临；生前预嘱的性质、可随时变更或撤销。
生前预嘱解读	医疗意愿明确、代理人指定、自愿签署；国外多具法律效力，我国目前属民间文档，《深圳经济特区医疗条例》已开展立法实践。
“我的五个愿望”	五个维度：要不要相关医疗服务、使不使用生命支持、希望别人怎么对待我、想让家人朋友知道什么、希望谁帮助我；含音乐陪伴、环境布置等个性化安排。
沟通技巧	在老人清醒、情绪稳定时以家常方式引入；用通俗语言解释创伤性抢救的局限；倾听不催促、不勉强签署；面对家属反对，引导其理解"尊重意愿才是最大的孝顺"。

维度	内容要点
家庭支持系统	家庭成员的心理疏导与照护协作，家庭会议的组织，照顾者负担的识别与支援。
文化因素与医疗决策	生死观、家庭权威结构及宗教信仰对治疗选择的影响，文化敏感性评估。

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

沟通技巧与伦理考量	坏消息告知、意愿探询、共同决策的步骤方法；案例解析与情景模拟演练。

（二）家庭支持与医疗决策专题培训（面向专业人员）。围绕三个维度提升专业人员在多元文化背景下的服务能力：

（三）“温情对话”社区宣传教育活动（面向社区居民）。

以"专业宣讲＋手工体验＋情感疏导"的组合形式，把生硬的医疗知识转化为有温度的人文关怀：

环节	内容要点
专题宣讲	病情沟通时机、共情表达方式、常见沟通困境，结合案例深入浅出讲解。
情景模拟互动	现场还原家庭沟通典型场景，对比“生硬说教”与“温柔共情”的不同感受，鼓励居民现场演练。
体验式手工活动	暖心手绘、寄语书写等低门槛创作，让参与者在书写中释放积压情绪，带走一份纪念。
一对一咨询区	医护与社工为有特殊需求的家庭提供个性化沟通指导，登记跟进服务需求。

六、社区工作评估与归档

过程评估：参与人数、出席稳定性、互动参与度与现场反馈；结果评估：活动前后安宁疗护知识知晓率对比（可选用汉化的安宁疗护知识量表）、死亡态度变化（如DAP-R 死亡态度描绘量表）、满意度问卷；跟进评估：咨询登记对象的转介落实情况与回访记录。归档：活动方案、签到表、影像资料、评估数据与咨询登记台账，注意保护参与者隐私。

云南大学青未护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）

参考来源

1. 世界卫生组织（WHO）：Palliative Care 实况报道及缓和照护定义（2002/2020）。

2. 国家卫生健康委办公厅：《安宁疗护实践指南（2025 年版）》（国卫办医政函〔2025〕332 号），2025 年 8 月；原《安宁疗护实践指南（试行）》（国卫办医发〔2017〕5 号）同步废止。

3. 国家卫生计生委：《安宁疗护中心基本标准（试行）和安宁疗护中心管理规范（试行）》（国卫医发〔2017〕7 号），2017 年 2 月。

4. 国家卫生健康委：安宁疗护试点工作相关通知（2017 年首批、2019 年第二批、2023 年扩围）；截至 2024 年底国家级试点覆盖 185 个市（区）。

5. 上海市卫生健康委员会：《上海市安宁疗护服务规范》（沪卫基层〔2020〕9 号），2020 年 8 月。

6. 新疆维吾尔自治区卫生健康委员会：《新疆维吾尔自治区安宁疗护服务规范》，2025 年。

7. 深圳市市场监督管理局：DB4403/T 521—2024《安宁疗护社会工作服务指南》，2024 年 11 月发布。

8. 周燕雯（Amy Chow）教授 ADAPTS 哀伤评估与干预配对模式（香港大学）；相关介绍见 Hospis Malaysia《Berita Hospis》2024 年第 1 期。

9. Klass, D., Silverman, P. R., & Nickman, S. L. (Eds.). Continuing Bonds: New Understandings of Grief. 1996.（持续联结理论）

10. Bowlby, J. Attachment and Loss. 1969—1980.（依恋理论）

11. Erikson, E. H. Childhood and Society. 1950.（心理社会发展阶段理论）

12. Prigerson 等：复杂性哀伤量表（ICG）；WHO ICD-11：延长哀伤障碍（PGD）诊断标准。

13. Zung, W. W. K.：焦虑自评量表（SAS，1971）、抑郁自评量表（SDS，1965）及标准分换算方法。

14. 福建医科大学等：安宁疗护社会工作核心能力框架构建——基于 E-CARE 模型的系统评价，BMC Palliative Care，2025。

15. Tomer, A., & Eliason, G. (1996). Toward a comprehensive model of death anxiety.

云南大学信息中心实践版（仅供内部使用，禁止外传）

Death Studies, 20(4).（死亡焦虑综合模型）

16. Frankl, V. E. Man's Search for Meaning. 1946.（意义疗法）

17. Butler, R. N. (1963). The Life Review: An Interpretation of Reminiscence in the Aged. Psychiatry, 26(1).（生命回顾理论）

18. Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). "Mini-mental state": A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3).（MMSE 认知功能筛查）

19. 《深圳经济特区医疗条例》（2022 年 6 月 23 日修订通过，2023 年 1 月 1 日施行）第七十八条：全国首次将生前预嘱写入地方性法规，医疗机构在患者不可治愈的伤病末期或者临终时实施医疗措施，应当尊重符合条件的生前预嘱。

20. 北京生前预嘱推广协会（LWPA）与"选择与尊严"公益网站（网站创办于 2006 年，协会于 2013 年注册成立）：《我的五个愿望》生前预嘱文本，涵盖医疗照顾、生命支持、对待方式、家人告知、代理人指定五个维度。

21. 殷露，杜若飞，崔盼盼，等. 社区居民安宁疗护认知现状及教育干预的研究进展. 军事护理， 2022, 39(12): 91—93.

22. 郑欣瑜，潘舒恒，陈伟强，等. 居民对安宁疗护的认知现状及选择意愿调查. 中国医学伦理学， 2021, 34(8): 1003—1009.

23. 殷露，等. 安宁疗护知识量表的汉化及在中老年社区居民中的信效度检验. 护理学杂志， 2023, 38(3): 109—112.

24. 许丽杰，王凌云，杨洁，等. 社区居民死亡态度、死亡应对与死亡教育需求的关系研究. 护理管理杂志， 2020, 20(12): 864—868.

25. Wong, P. T. P., Reker, G. T., & Gesser, G. (1994). Death Attitude Profile-Revised (DAP-R). In R. A. Neimeyer (Ed.), Death Anxiety Handbook.（死亡态度描绘量表修订版）

26. Rothman, J. (1979). Three models of community organization practice: A macro-practice perspective.（社区工作三大模式：地区发展、社会策划、社会行动）

云南大学博术老实践队（仅供内部便用，禁止外传）

后 记

这本手册从"什么是安宁疗护"写起，一路写到个案、小组与社区中的具体做法。编写过程中我们始终记得一个朴素的出发点：安宁疗护不是一份关于"如何离开"的技术清单，而是一种关于"如何好好走到终点"的照护哲学——既不加速死亡，也不延缓死亡，只是陪着患者和家人，把剩下的路走得尽量安稳、尽量像自己。

手册中的每一个评估工具、每一条干预参考线，最终指向的都是同一件事：把选择权交还给患者，把尊严留到最后一刻。生前预嘱的推广让我们看到，越来越多的人开始在清醒、从容的时候谈论死亡；社区宣教活动现场，居民在手绘布包上写下"好好说话，温柔相伴"——这些微小的瞬间，正是安宁疗护最真实的样子。

我们深知，手册所能写下的只是方法，而方法背后的倾听、陪伴与不忍之心，需要每一位医务社工在日复一日的服务中亲身体认、慢慢生长。愿这本手册成为一线工作者手边一份可靠的参考，也成为更多人愿意平静谈论生命终点的开始。

感谢所有在安宁疗护道路上探索与实践的同行者。手册将随政策发展与实务积累持续修订完善，欢迎提出宝贵意见。

2026 年 10 月

云南大学青禾护老实践队（仅供内部使用，禁止外传）